

Initiation d'un antidépresseur : syndrome "d'activation" ou virage maniaque ?

 Les antidépresseurs ont de multiples indications en médecine (dépression, troubles anxieux, douleurs chroniques, etc.) avec des preuves bien documentées de leur efficacité.

 Pour bénéficier de ces effets thérapeutiques et minimiser les risques, il vaut mieux être bien informé.e des possibles effets indésirables en début de traitement. Ne pas les connaître peut entraîner des arrêts injustifiés :

- ⚠ le délai d'action des antidépresseurs sur les symptômes dépressifs est d'au moins deux semaines, même si on peut ressentir plus rapidement des effets positifs
- ⚠ au début du traitement, il est fréquent de ressentir une aggravation de son état, voire l'apparition de nouveaux symptômes

 Ces symptômes sont regroupés sous le terme de syndrome "d'activation" ou "nervosité/anxiété" :

- ⚠ tension interne, fébrilité (un peu comme on a bu trop de café)
- ⚠ aggravation de l'anxiété, attaques de panique
- ⚠ insomnie
- ⚠ irritabilité
- ⚠ agitation

⚠ apparition ou aggravation d'idées suicidaires

NB : l'expression "levée d'inhibition" est encore souvent utilisée en France pour décrire un syndrome proche

 Ce syndrome "d'activation" :

- ⚠ est lié au début des effets pharmacologiques de l'antidépresseur sur la transmission sérotoninergique
- ⚠ est plus fréquent chez les enfants, adolescents et jeunes adultes
- ⚠ apparaît dès les 1er jours de traitement
- ⚠ disparaît en général rapidement après la 1ère semaine
- ⚠ est plus fréquent en cas d'augmentation rapide des doses
- ⚠ peut réapparaître à chaque augmentation de dose

 C'est un effet pharmacologique attendu, qui en règle générale ne justifie pas l'arrêt définitif de l'antidépresseur. Il peut nécessiter :

- ⚠ une diminution des doses voire un arrêt temporaire de l'antidépresseur le temps que les symptômes disparaissent
- ⚠ l'association d'un traitement anxiolytique ou hypnotique en début de traitement

 Ce syndrome peut être difficile à différencier d'un virage (hypo)maniaque. Plusieurs symptômes sont communs, même si des caractéristiques diffèrent :

- ⚠ le virage de l'humeur survient plus tardivement, après plusieurs jours/semaines de traitement

des symptômes maniaques plus spécifiques sont présents : accélération des idées et du débit verbal, hyperactivité motrice, réduction du besoin de sommeil

⚠ Un virage de l'humeur impose en règle générale l'arrêt de l'antidépresseur

🧠 En pratique, un syndrome d'activation peut s'associer à/évoluer vers un virage de l'humeur s'il existe une vulnérabilité bipolaire :

1^{er} dépression avant 25 ans

dépression avec symptômes psychotiques ou ralentissement moteur

fluctuations de l'humeur, surtout si caractère saisonnier

antécédents familiaux de bipolarité ou de suicide

! Surtout chez les jeunes, une surveillance au minimum hebdomadaire est indispensable après l'initiation d'un traitement antidépresseur. On ne devrait plus voir de primo-prescription d'antidépresseur pour un mois voire plus, sans RDV intermédiaire, et sans information sur les signes d'alerte.

Références

<http://dx.doi.org/10.1016/j.aip.2017.06.003>

<http://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.107.048371>

